11. DAS HERZ : ZUSAMMENFASSUNG UND PRAKTISCHE IMPLIKATION

DAUER : 11:02 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht die Bedeutung des Herzens in der Embryonalentwicklung und positioniert es als Treffpunkt der Lebenskräfte zwischen Spermium und Eizelle. Es wird gezeigt, wie sich das Herz innerhalb der Primitivrinne bildet und mit Schlüsselstrukturen wie dem Neuralrohr und dem Mesoderm interagiert. Die Konzepte von Diastole und Systole werden ebenfalls behandelt, mit besonderem Augenmerk darauf, wie diese Bewegungen in der osteopathischen Praxis beobachtet und integriert werden können. Praktiker lernen, embryonale Fulkren zu nutzen, um Herz- und Gehirnsysteme zu revitalisieren und auszugleichen, indem sie ihren Ansatz durch relevante Stützpunkte verfeinern.

DAS HERZ: ZUSAMMENFASSUNG UND PRAKTISCHE IMPLIKATIONEN

DAS HERZ: SYMBOLISCHER TREFFPUNKT

Das **Herz** wird als symbolischer Treffpunkt zwischen dem **Spermium** und der **Eizelle** betrachtet. Hier etabliert sich ein **fundamentales Muster**, das sich sogar auf einer Polaritätsebene manifestiert.



ABB. — Zellulärer Embryo

FRÜHES AUFTRETEN UND ENTWICKLUNG

Das Auftreten des Herzens ist besonders interessant auf der Ebene der **Primitivrinne**.

Es ist der Überrest unter S2, dem terminalen Ende der **Notochord** und dem Ort der Empfindung.

Wir betrachten es in seiner fazialen Umgebung und seiner entwicklungsbedingten Bewegung. Es wird bei der Schließung und Etablierung des kleinen Beckens in die **sekundäre Neurulation** re-integriert.

Die sekundäre Neurulation ist dieser Raum zwischen dem **Filum terminale** und dem **Kaulalwulst**, der ein differentielles Wachstum des **Neuralrohrs** im Vergleich zum anterioren **Endoblasten** beinhaltet, mit einer Öffnung des Lumens.

Der anteriore Endoblast ist der embryonale Endoblast, aber hier, auf **mesoblastischer** Ebene und auch auf der Ebene des Herzens.

In dieser Welle mit der Primitivrinne, die in S2 endet, ist bereits eine **primitive Herzkraft** vorhanden. Die vermutete Lokalisation im Epiblasten ist Teil des Herzpotentials, es ist die früheste identifizierte Lokalisation.

Die **kardiogenen Zellen** befinden sich auf der Ebene des Epiblasten, in der präsumptiven Schicht des Epiblasten, noch vor der Mesodermbildung.

Wir werden diese präsumptive Lamina wiederfinden. Einer Wachstumswelle folgt eine Stauung, dann die Integration und das Zusammentreffen der beiden Röhren, von der Peripherie durch die **Amnionhöhle** organisiert. Das Neuralrohr, das Herzrohr und die Integration des Zwerchfells tragen zur Etablierung des Herzens bei.

Dies geschieht gleichzeitig mit dem Verschluss des Neuralrohrs und der Integration des externen **Zöloms** in das interne Zölom.

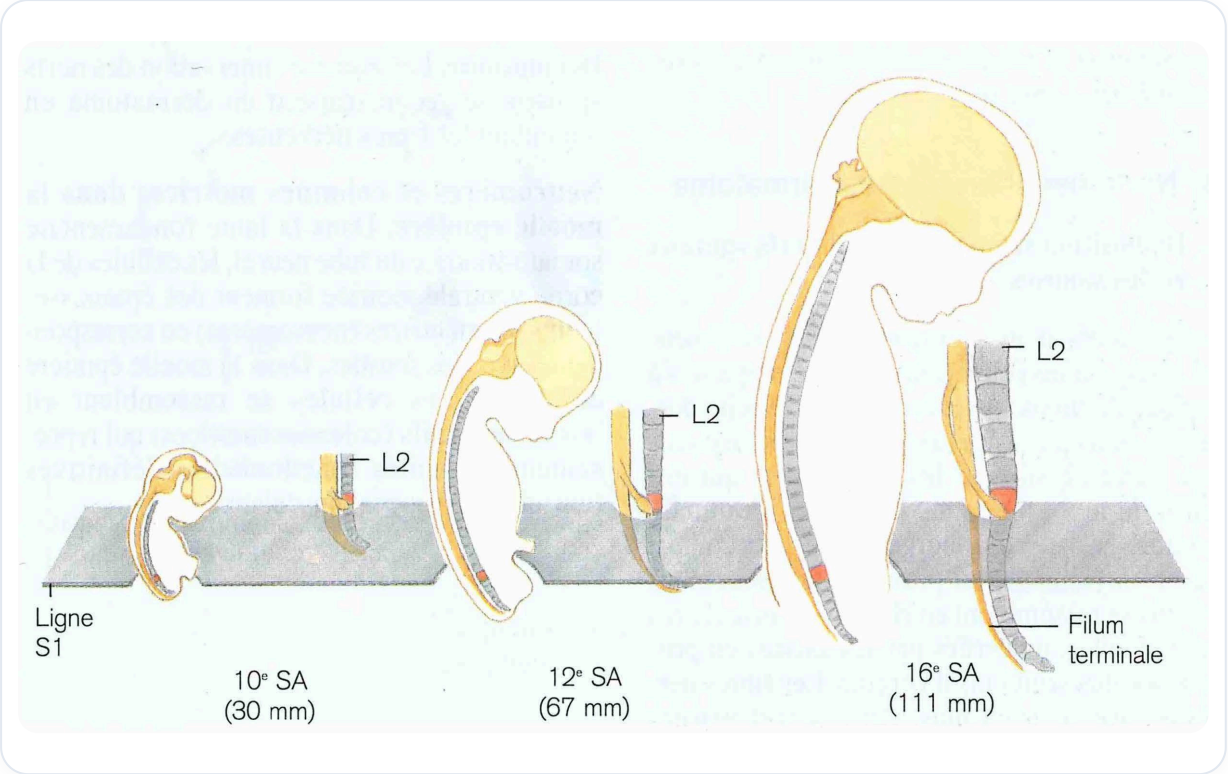


ABB. — Relatives Wachstum des Rückenmarks

DIE PRIMITIVRINNE UND DAS KARDIALE FULCRUM

Der früheste identifizierbare Ort ist die Primitivrinne.

Die Notochord endet auf der Höhe von S2. Der Raum zwischen S2 und dem Ende der Primitivrinne enthält den Überrest der Primitivrinne.

Das **embryonale Fulcrum** des Herzens liegt auf dem Steißbein.

Das Herz nimmt dann eine eher **diastolische** Haltung ein, sucht Energie und Volumen. Es sinkt in seiner Bewegung wieder ab.

Das Herz weist auch ein Fulcrum auf, d.h. einen Ursprungspunkt, den es unterschiedlich manifestieren kann.

HERZBEWEGUNGEN UND -STRUKTUREN

Es etabliert sich eine Bewegung zwischen dem **Gehirn**, mit der **Kephalisation**, und dem Herzen, der **Kardialisierung**, die ihr Zusammentreffen ermöglicht.

Gleichzeitig treffen sich die beiden Endokardröhren in der Mittellinie. Es folgt das **Looping** des Herzens, dann die Etablierung des **Herzsinus** und des **Aortenbogens** mit den großen Gefäßen.

Die **Vena-cava-Achse** dient als Referenzpunkt.

Es ist wichtig zu beobachten, ob sich das Herz auf einer systolischen oder diastolischen Ebene ausdrückt. Fazial sucht es eher die Diastole oder die Systole.

Im Vergleich zum Ilium sucht es viel mehr die **Horizontalität**, was auf eine diastolische Bewegung hindeutet. Wir können bis zur Suche nach dem **Aortenpuls** gehen.

GEHIRN- UND HERZENTWICKLUNG

Wir werden die Entwicklung des Gehirns schrittweise in Bezug auf die entwicklungsbedingte Bewegung integrieren.

Die erste Entwicklungsbewegung des Gehirns war die **Expansion**. Diese Expansion hing von der **Längsachse** oder der **Mesenterialachse** ab. Sie hängt von der Dottersackintegration ab, deren Überrest sich auf der Mesenterialachse wiederfinden wird.

Dann ist eine weitere wichtige Ebene für die Ernährung das System zwischen der **Milz** und der **Leber**, mit dem Rückfluss zum Herzen über die **Vena cava**. Dann wird sich die Aorteninformation durch vier oder zwei Eintrittspforten manifestieren: karotidisch, oben, unten, vertebral.

Wir integrieren so die Entwicklung des Gehirns mit dem Herzen und dem Mesenterialsystem. Bei der Arbeit am Gehirn beobachten wir, welches Feld sich öffnen muss. Wir können die Wahrnehmungen verfeinern, um die zu bearbeitenden Bereiche zu bestimmen, zum Beispiel am Karotissystem im Verhältnis zum Herzen.

Dies kann durch einfache Stützpunkte geschehen, seien es embryonale Fulcra oder Stützpunkte in der Konstruktion, um die Regenerationskraft neu zu beleben.

Ein Fulcrum ist ein Entstehungspunkt. Die gesamte Entwicklungskraft, wie die Integration des **Dottersacks** in eine Arterie (ein Überrest des Entwicklungsweges und kein embryonales Fulcrum), liegt zwischen dem Fulcrum und der Finalität.

Wir beginnen, das Spiel wahrzunehmen, in das wir uns begeben werden, denn wir werden an spezifischen Arterien arbeiten. Ziel ist es, die **volle Homöostase**, die volle Vitalität, die volle Gesundheit wiederherzustellen.

URSPRUNG DES FULCRUMS UND MESODERMALE WELLE

Ich werde den Ursprung seines Fulcrums berühren, der sich indirekt auf kokzygealer Ebene wiederfindet und sich dann nach und nach durch die entwicklungsbedingte Bewegung des **Manotococcus**, dieser Welle mit dieser Aspiration auf der Ebene des Mesoderms, in sein System integrieren wird.

Es ist eine Information, die umstrukturiert, revitalisiert, dem Gewebe Kraft zurückgibt, die Funktion wiederherstellt.

Die Entwicklung der embryonalen Kräfte ermöglicht die Entwicklung der Hauptfunktion des Systems.

DIE ZENTRALE ROLLE DES ZWERCHFELLS

Der große Meister für all dies wird das **Zwerchfell** sein. Es geht darum, sich gut auf diesem Zwerchfell mit drei Ebenen zu positionieren:

- **Amnionhöhle** auf der transversalen Ebene
- **Thorakal**
- **Abdominal**

Diese Integration des Zöloms und gleichzeitig die Integration von Gehirn, Herz, Zwerchfell, dem hinteren Teil des Peritoneums, um zum **Beckenboden** zurückzukehren und durch dieses Kippen der Leber die gesamte Schließung meiner Linea alba wiederherzustellen, die die gesamte **urogenitale** Information liefern wird.

DIE LINEA ALBA UND DAS UROGENITALSYSTEM

So wird es sich bilden. Die **Linea alba** repräsentiert die vollständige Integration der urogenitalen Ebene, das ist ihre endgültige Geschichte.

Auf dieser Linea alba können wir nach Konzentrationen von kristallisierten Zeiten suchen, denn es ist eine Wahrscheinlichkeitslinie in Bezug auf das **Erythrozyt**, die Bildung der Blutkörperchen, also eine Zukunft, in der die Ebene der **Kopula** auch deine Zukunft ist.

Im Moment des Austritts findet die Dehnung statt, und so wird sich das gesamte äußere und innere Genitalsystem auf dieser Ebene der vorderen Linea alba integrieren. Sie endet, um sich neu aufzubauen.

Auf der Ebene der Blutkörperchen schreitet die **Erythrozytose** oder die **Gonocythose** voran. Irgendwann macht der Embryo eine Bewegung. Es gibt eine Initiationslinie im Leben. Im Moment der Geburt muss diese Linie, die Linea alba, geöffnet und das Leben initiiert werden.

EMBRYONALE FULCRA UND ARTERIELLES SYSTEM

Die Idee wird sein, die richtigen **embryonalen Fulcra** wiederherzustellen. Das arterielle System muss als **Oktopus** betrachtet werden.

Morgen werden wir das arterielle System im Gesicht detailliert beschreiben, da es eine trophische Zugangspforte zum Gehirn ist. Es wird notwendig sein, die Entwicklung des Karotissystems und des Vertebralsystems zu verstehen.

Diese beiden Systeme, mit all den Informationen über den **Willis-Polygon** und die anterioren, mittleren, posterioren **Hirnarterien**, sowie die Sinus oder Klappen (von Brechet oder Thierry Goïdienne usw.), sind Gleichgewichtsräume.

ZEREBRALES VASKULÄRES GLEICHGEWICHT

Wir brauchen ein Gleichgewicht zwischen vaskulärer Zufuhr und venösem Rückfluss. Man weiß heute, dass es ein **lymphatisches System** im Gehirn gibt.

Um Überschüsse zu eliminieren, können manche eine **lymphatische** oder venöse **Stauung** im Gehirn haben. Man sieht es bei Menschen, die etwas geschwollen, etwas ödematös sind. Der Rückfluss findet nicht statt.

Eine ausgleichende Arbeit auf venöser Ebene ist dann notwendig, sei es auf der Ebene der **oberen** oder unteren **Vena cava**. Dies ist wichtig, um Stauungen zu vermeiden, insbesondere im Bereich der Ohren, und alles, was nicht abfließen kann.

THERAPEUTISCHE HALTUNG

Ich positioniere mich gut auf der Höhe des Steißbeins und des Herzens. Man kann den **Angulus Ludovici**, den vaskulären Stamm vom aortisch-pulmonalen Typ, visualisieren.

Das Herz liegt auf der **Längsachse**. Nur ein Teil davon ist nach links dilatiert, mit einer Entwicklungsphase an seiner Herzspitze links.

Sie positionieren sich auf der Längsebene des Herzens. Indem ich hier ein Fulcrum und einen Stützpunkt am Herzen gebe, ist meine Aufmerksamkeit im Raum, neutral, und wir lassen das System sich organisieren.